## 二、骨与关节结核 肺结核通过血源播散引起

### （一）概述

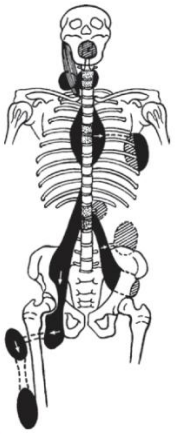


图 71-3 脊柱结核寒性脓肿的流注途径

1.好发于负重大、活动多、易慢性损伤、肌肉附着少处 肌细胞对TB有一定抵抗作用
椎弓根肌肉附着多不容易出现结核,但血供丰富,容易发生肿瘤转移

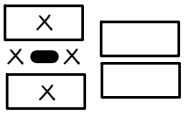
2.发病率：**脊柱结核＞膝关节结核＞髋关节结核**（鸡西宽冷面）
VS化脓性关节炎：髋关节>膝关节

3.临床表现 如果只有椎体破坏而没有椎间隙狭窄不要先想到结核

①多呈单发病灶 单发病灶蔓延扩展

②起病多缓慢，可有低热、盗汗、消瘦等全身症状

③疼痛是最先出现的局部症状



④**椎体或关节破坏、椎间隙或关节间隙狭窄** 破坏+狭窄

⑤**寒性/冷脓肿**（少数患者就诊的原因）：多无红、热，如脊柱寒性脓肿可见**椎旁软组织影、腰大肌影增宽**



图 71-6 边缘型脊柱结核 X 线表现为骨质破坏和椎间隙狭窄

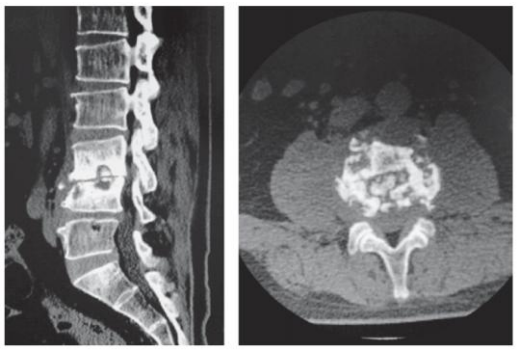


图 71-7 脊柱 CT 显示椎体边缘骨破坏、死骨和腰大肌脓肿

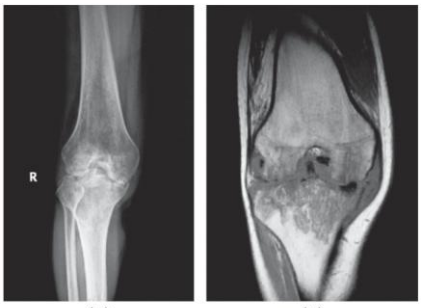


图 71-8 脊柱 MRI 显示结核病变进入椎管压迫脊髓




（1） （2）

图 71-11 髋关节结核普通 X 线片（1）及 MRI 影像（2）




（1） （2）

图 71-12 膝关节结核普通 X 线片（1）及 MRI 图像（2）

4.早期诊断：**MRI**（核磁）磁共振对软组织、对液体非常敏感
e.g股骨头骨软骨病、股骨头坏死、急性化脓性骨髓炎、骨关节结核

5.治疗原则

①**抗结核药物治疗为主**，同时局部制动

②有指征且无禁忌症再手术。**抗结核 2-4 周→手术→抗结核≥12 个月**。手术禁忌症为**全身中毒症状明显**、或伴其它脏器活动期结核 直接做手术会导致感染扩散 VS慢性骨髓炎作病灶清除术至少术前2天用抗生素

③**不主张对寒性脓肿反复抽脓、注入抗结核药和切开引流**（会形成窦道）。仅寒性脓肿有混合感染、全身中毒症状明显者可考虑寒性脓肿切开引流 此时不能做病灶清除术,但不能不管